Arteritis de células gigantes: ¿el fibrinógeno al mes predice la recaída mejor que la PCR?

Pichon S, Leurs A, Mortain L, et al. Biomarker trajectories and risk of relapse in giant cell arteritis: a multicenter study. *Semin Arthritis Rheum*. 2026;81:153103. doi:10.1016/j.semarthrit.2026.153103

Versión 1.0 · Revisado el 8 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
Una hipótesis interesante y barata de comprobar: medir fibrinógeno además de PCR durante el descenso de glucocorticoides. Pero el punto de corte salió de los mismos datos y no tiene validación externa.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Exploratorio
Retrospectivo, con el análisis clave en 59–71 pacientes, sin datos sistemáticos del descenso de glucocorticoides y con una muestra para el ROC con dos tercios de recaídas, más que la mitad observada en el subgrupo.

CUIDADO AL INTERPRETAR
VPP de 93 %, ¿en quién?
Con 66 % de recaídas, hasta una prueba sin valor tendría un VPP de 66 %. El 93 % hay que leerlo contra esa base, y bajaría si recayeran menos pacientes.

En 30 segundos. Cohorte retrospectiva de tres hospitales franceses con 465 pacientes con arteritis de células gigantes (ACG) diagnosticados entre 2000 y 2023. El **34 % recayó en 5 años**, 81 % de las veces durante el descenso de glucocorticoides (mediana 10 mg/día; RIC 7–20). Cefalea, claudicación mandibular, polimialgia y captación aórtica en PET (entre las PET positivas) al diagnóstico se asociaron a más recaídas; la PCR, la VSG y el fibrinógeno **al diagnóstico** no. En un subgrupo con mediciones mensuales (2017–2022), tener el **fibrinógeno normal al mes** se asoció a mucho menos riesgo de recaída en los 2 años siguientes (**HR 0.14**; IC 95 % 0.07–0.28; n = 70), mientras que tener la PCR normal no (HR 1.10). El fibrinógeno al mes discriminó bien (AUC 0.82) y un corte exploratorio de **3.77 g/L** tuvo sensibilidad de 72 % y especificidad de 90 %. En las recaídas, la PCR y el fibrinógeno estaban altos en 91 %, pero la **VSG solo en 39 %**.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Un punto de corte nacido de los propios datos: por qué el corte "óptimo" de una curva ROC y su sensibilidad y especificidad salen optimistas sin validación, por qué un AUC con 59 pacientes es impreciso, y por qué el VPP y el VPN cambian según cuántos pacientes tienen el desenlace en la muestra. Además: análisis por hito temporal (*landmark*) y exclusiones que cambian la muestra.

1 La pregunta clínica (PICO)

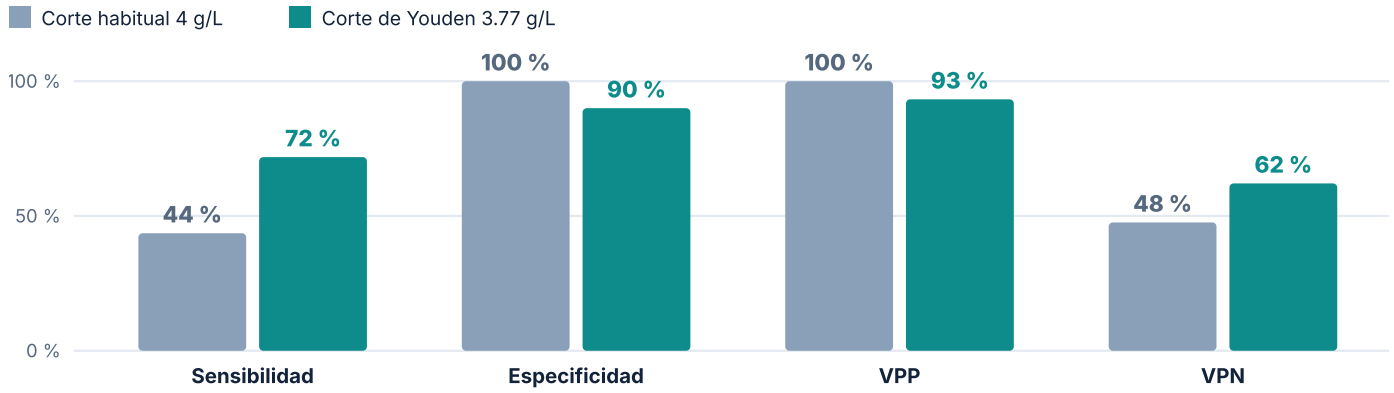
P · POBLACIÓN	465 adultos ≥50 años con ACG que cumplían los criterios del ensayo GiACTA (cuadro clínico de ACG o polimialgia más biopsia temporal compatible o vasculitis de grandes vasos en angiotomografía, resonancia o PET). Edad media 72 años; 67 % mujeres. Mediana de dosis inicial de glucocorticoides 55 mg/día. La pregunta del fibrinógeno al mes se analizó en 70 pacientes del subgrupo 2017–2022 (59 para el ROC).
I · EXPOSICIÓN	Fibrinógeno plasmático normal (≤4 g/L) un mes después del diagnóstico. También se analizaron los factores clínicos y de imagen al diagnóstico, y las trayectorias de PCR y fibrinógeno en 2 años.
C · COMPARADOR	Fibrinógeno todavía elevado al mes; y la PCR normal (≤5 mg/L) al mes como marcador alternativo.
O · DESENLACE	Recaída: reaparición de síntomas de ACG, con o sin reactantes altos, que obligó a escalar o modificar el tratamiento (mayor o menor según EULAR 2018).

2 Diseño

TIPO	Cohorte retrospectiva multicéntrica (Lille, Arras y Dunkerque) a partir de códigos CIE-10. Dos partes: la cohorte completa (n = 465) para factores al diagnóstico, y un subgrupo diagnosticado en 2017–2022 con PCR y fibrinógeno mensuales hasta la recaída o 2 años (n = 135; fibrinógeno suficiente en 71).
EXCLUSIONES	Los pacientes con tocilizumab desde el diagnóstico (n = 13) no entraron en los análisis longitudinales de PCR y fibrinógeno, porque el fármaco suprime la PCR y el fibrinógeno.
ANÁLISIS	Cox univariable para factores basales. Para el mes 1 se usó un **hito temporal**: solo pacientes sin recaída ni censura antes del mes 1 y solo recaídas posteriores. Curva ROC del fibrinógeno al mes con corte por índice de Youden e IC por *bootstrap*; para el ROC se excluyó además a quien no había recaído pero tenía menos de 24 meses de seguimiento. Modelos conjuntos de clases latentes para las trayectorias.
FINANCIAMIENTO	Sin financiamiento específico. Varios autores declaran consultorías con la industria, fuera del trabajo.

3 Resultados

Fibrinógeno al mes para predecir recaída en los 24 meses siguientes (59 pacientes, 39 recayeron)



"Positivo" = fibrinógeno por encima del corte al mes (predice recaída). AUC 0.82 (IC bootstrap 0.69–0.91).
En esta muestra recayó el 66 %, lo que infla el VPP y deprime el VPN.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto del artículo. No reproduce figuras originales.

HALLAZGO	RESULTADO
Recaída a 5 años (cohorte completa, n = 465)	159/465 (34.2 %; mediana de seguimiento 3.3 años; 41.7 % en todo el seguimiento); mediana hasta la primera, 11.7 meses; 81 % durante el descenso; 25 % mayores
Factores al diagnóstico (Cox univariable)	Cefalea HR 1.70 · claudicación mandibular HR 1.76 · hipersensibilidad del cuero cabelludo HR 1.85 (solo los primeros 24 meses) · polimialgia HR 1.38 · captación aórtica (entre PET positivas) HR 1.79
PCR, VSG y fibrinógeno al diagnóstico	Sin asociación con recaída
Fibrinógeno normal al mes (n = 70)	**HR 0.14 (0.07–0.28)**; ajustado por PCR, HR 0.13; libre de recaída a 6 meses: 81 % vs. 24 %
Análisis de sensibilidad (ajustes por separado)	Por dosis inicial y pulsos: HR 0.16 (0.07–0.33; n = 67) · por manifestaciones craneales: HR 0.15 (0.07–0.32). Sin ajuste por el ritmo de descenso
PCR normal al mes (n = 70)	HR 1.10 (0.55–2.22); ajustada por fibrinógeno, HR 1.53 (0.74–3.14). En cambio, un nadir de PCR más alto en el primer mes sí se asoció: HR 1.15 por mg/L (1.02–1.29; n = 134)
Reactantes elevados en la recaída	PCR 91 % · fibrinógeno 91 % · VSG 39 %
Trayectorias (modelo conjunto)	PCR: 4 patrones (aumento temprano, intermedio, tardío y bajo estable, con muy pocas recaídas). Fibrinógeno: 2 patrones. Los autores advierten que la separación de las curvas es en parte producto del modelo, que incluye el tiempo a la recaída

4 Cómo leer estos resultados

- **El corte de 3.77 g/L salió de la misma muestra.** DATO DEL ARTÍCULO El corte se eligió con el índice de Youden sobre los mismos 59 pacientes en que se midió su rendimiento; los autores lo llaman exploratorio y piden validación externa. El *bootstrap* se usó para el IC. INTERPRETACIÓN Escoger el corte que mejor separa a estos pacientes maximiza su rendimiento en ellos; en otra cohorte suele rendir menos (optimismo). El IC del corte (3.45–3.97 g/L) llega casi a 4.
- **Una muestra con dos tercios de recaídas.** DATO DEL ARTÍCULO Para el ROC se excluyó a quien no había recaído pero tenía menos de 24 meses de seguimiento; quedaron 59, de los cuales 39 recayeron (66 %); en el subgrupo 2017–2022 completo, la recaída a 2 años fue de alrededor de 50 %. INTERPRETACIÓN Con cálculo propio y la misma sensibilidad y especificidad: si recayera el 50 %, el VPP sería de cerca de 88 % y el VPN de 76 %; si recayera un tercio, como en la cohorte completa (con otro horizonte), 79 % y 86 %. El VPP y el VPN no son propiedades de la prueba, sino de la prueba en esa población.
- **El hito del mes 1 está bien pensado.** DATO DEL ARTÍCULO Solo se contaron recaídas después del mes 1 y en pacientes sin recaída antes. INTERPRETACIÓN Evita el sesgo de tiempo inmortal: no se compara a quien "llegó" al mes 1 con quien recayó antes de poder ser medido.
- **¿Por qué la PCR normal al mes no se asoció?** DATO DEL ARTÍCULO Un nadir de PCR más alto en el primer mes sí se asoció a recaída (HR 1.15 por mg/L). INTERPRETACIÓN Si la mayoría normaliza la PCR al mes (el artículo no da la proporción), un umbral binario de 5 mg/L separa poco. El fibrinógeno, de vida media más larga, podría reflejar mejor la inflamación residual. Plausible, no demostrado. Y como sin normalizar el fibrinógeno solo el 24 % seguía sin recaída a 6 meses, el marcador quizá detecta enfermedad todavía activa más que predecir recaídas tardías.
- **Lo que no se midió.** DATO DEL ARTÍCULO El ritmo de descenso no se recogió de forma sistemática ni estuvo estandarizado. La recaída se definió por decisión clínica de escalar el tratamiento. INTERPRETACIÓN La gravedad basal o un manejo distinto podrían explicar a la vez un fibrinógeno alto y más recaídas; los autores ajustaron por dosis inicial, pulsos y síntomas craneales, no por el descenso. Si el médico veía la PCR o el fibrinógeno al decidir que había recaída, el 91 % de reactantes altos en la recaída es en parte circular (sesgo de incorporación), y un fibrinógeno alto al mes pudo aumentar la sospecha (sesgo de detección).

CONCEPTO CLAVE · OPTIMISMO, PREVALENCIA Y VALIDACIÓN

Optimismo: cuando el corte o el modelo se elige y se evalúa en los mismos datos, el rendimiento sale mejor de lo que será en pacientes nuevos. Se corrige con validación interna (*bootstrap* o validación cruzada que repite la elección del corte) y, sobre todo, con **validación externa** en otra cohorte. **Prevalencia:** la sensibilidad y la especificidad son relativamente estables, pero el VPP sube y el VPN baja cuanto más frecuente es el desenlace en la muestra; nunca traslades un VPP de un estudio a tu consulta sin revisar cuántos tenían el desenlace. **Asociación no es predicción:** un HR de 0.14 dice que el grupo con fibrinógeno normal recae menos en promedio, no que el fibrinógeno clasifique bien a cada paciente.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Definición de ACG y recaída	Criterios GiACTA y definiciones EULAR 2018, aplicadas igual en los tres centros.	Declarado por los autores
● Hito temporal	Solo recaídas después del mes 1 en pacientes libres de recaída al mes 1.	Confirmado
● Retrospectivo y muestra pequeña	Análisis clave en 59–71 pacientes (ROC 59; Cox al mes 70; trayectorias 71); fibrinógeno no medido de forma sistemática.	Reconocido por los autores
● Selección	109 de 244 tamizados no entraron al análisis longitudinal. En el modelo de trayectorias del fibrinógeno entraron 71 de 135; los 64 excluidos tenían PCR basal más alta (fibrinógeno basal solo en 29). No se reporta para las muestras de Cox ni del ROC.	Reconocido por los autores
● Descenso de glucocorticoides	No estandarizado ni recogido de forma sistemática; confusión residual posible.	Reconocido por los autores
● Sin validación externa	Corte de 3.77 g/L exploratorio; VPN de 62 %.	Reconocido por los autores
● Tocilizumab	Se excluyó a los 13 con tocilizumab al diagnóstico; los resultados no aplican a quien empieza con inhibidor de IL-6.	Reconocido por los autores

Pregunta de repaso: una paciente con ACG lleva un mes con prednisona; la PCR ya es normal y el fibrinógeno está en 3.9 g/L. Un colega propone "no bajar el esteroide porque el fibrinógeno predice recaída con un VPP de 93 %". ¿Qué le respondes?
Respuesta. Que 3.9 g/L es normal con el corte habitual de 4 y "positivo" solo con el corte exploratorio de 3.77, elegido en los mismos 59 pacientes, en los que recayó el 66 %. Si en su consulta recaen menos pacientes, el VPP sería menor. Sirve como señal para vigilarla más de cerca durante el descenso (síntomas, PCR y fibrinógeno seriados, e imagen si hay duda), no como regla para cambiar el esquema de glucocorticoides por sí solo.

¿Qué aprendí de medicina?

- La recaída de la ACG ocurre sobre todo en el descenso (mediana 10 mg/día; RIC 7–20).
- La VSG estuvo alta en solo 39 % de las recaídas.
- Con tocilizumab, PCR y fibrinógeno quedan suprimidos (dato conocido; aquí se excluyó a esos pacientes).

¿Qué aprendí de investigación?

- Un corte elegido en los mismos datos sale optimista.
- VPP y VPN dependen de la prevalencia de la muestra.
- HR bajo ≠ buena clasificación individual.

6 Referencias

1. Pichon S, Leurs A, Mortain L, Behal H, Dalhi N, Jouvray M, et al. Biomarker trajectories and risk of relapse in giant cell arteritis: a multicenter study. Semin Arthritis Rheum. 2026;81:153103. doi:10.1016/j.semarthrit.2026.153103

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.